



ÚVN

ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6

IČ: 61383082

ORT Klin. ortopedie 1. LF UK a ÚVN
přednosta: prof. MUDr. Michal Tuček, Ph.D.
ORTD Stand.lůžka stanice 1-trauma
tel.+420 973 203 281, e-mail: info@uvn.cz

PŘEKLADOVÁ ZPRÁVA

Pacient: **Mgr. SVOBODOVÁ EVA**

RČ: **426126/455**

ZP: **207**

Bytem: Sídlištní 245/18G, Praha 6, 16500

Hospitalizována od: **27.08.2026** do: **07.09.2026** (CHIR JIP 28. – 29.8.)

Váš názor nás zajímá



www.uvn.cz/spokojenost

ZÁKLADNÍ ANAMNÉZA:

PL: MUDr. Lindovský, P-6

RA: bezvýznamná k současnému onemocnění

OA: prodělal běžné dětské nemoci, vážněji nestonala,

Operace:

- HLP

- CHT a RT 2025 pro ca. prsu, nyní na biologické a hormonální léčbě

* 2008 TEP levé kyčle (FNM)

* HyE s AE pro myomy v 56 letech

* TE v dětství

* operace nosních polypů

* st.p. operaci varixů bilat.

* 2025 - ablace levého prsu

* 2015 - OS periprotetické fr. levého femuru - Dr. Chochola

Úrazy: 27.8.26 - pád při vystupování z výtahu

Aktuálně styk s virovým respiračním onemocněním 0

GA: porody 3, potraty 1 (UPT), menses do 56 let

Abusus: nekouří, alkohol příležitostně, dieta 3

SA: bydlí v bytě, s manželem

PA: SD

Alergie: pylly

FA: FLONIDAN 10MG TBL NOB

PO 1-0-0

EGILOK 25MG TBL NOB

PO 1-0-1

VERZENIOS 100MG TBL FLM

PO 1-0-1

EGISTROZOL 1MG TBL FLM

PO 1-0-0

SORVASTA 20MG TBL FLM

PO 0-0-1

VIDEMEL 600MG/400IU TBL FLM

PO 0-0-1

NYNĚJŠÍ ONEMOCNĚNÍ: Pacientka přijata dne 27.08.2026 na standardní lůžkové oddělení po pádu, periprotetická zl. femuru vlevo Vancouver B3, st.p. TEP kyčle a po OS DFP. Poop. Monitorace na CHIR JIP bez komplikací.

STAV PŘI PŘIJETÍ:

Váha: 87.000 kg

TK: 132/80 mmHg

Počet dechů: 16

Výška: 152.0 cm

Tep: 82

Teplota: 36.6 °C

Status presens: Normosomní konstituce, přiměřené výživy a rozvoje svalstva, plně orientovaná všemi kvalitami, anikterická, hydratovaná, afebrilní, spolupracuje. Hlava i krk bez patologického nálezu, zornice izokorické, fotoreakce pozitivní, šlje volná, štítná žláza nezvětšena, hrudník klenutý, dýchání čisté bez vedlejších poslechových fenoménů, akce srdeční pravidelná - 2 ozvy ohraničené, břicho měkké prohnatné, játra i slezina nezvětšeny, tapottement bilat. negativní, končetiny bez poruchy prokrvení, bez poruchy inervace, bez známek TEN. Status localis: levé stehno - Hydrotac s min. sang. prosakem ve střední části, RD+80 ml, hybnost kyčle algicky omezena, periferie bez alterace

VYŠETŘENÍ: Laboratorní vyšetření a předoperační závěr jsou bez kontraindikací k výkonu v celkové anestézii.

VÝSLEDKY HEMATOLOGIE: 28.08.26: KSproTP: O+; SCP: NEG; S_ABKOC_: E_KOMP;
VÝSLEDKY BIOCHEMIE: 28.08.26: pH: 7.331; pO₂: 4.68; pCO₂: 6.51; BE: 0; SBC: 23.5; HCO₃: 25.3; sO₂: 58.5; Ca⁺: 1.14; lakto: 1.7; Na a: 139; K as: 4; Cl a: 105; Gl: 6.9; Hbg: 87; Hmt: 27; ABR: Věna;
30.08.26: PDW: 10.3; leu: 5.39; ery: 2.81; Hb: 87; htk: 0.25; MCV: 88; MCH: 31; RDW: 14.3; trc: 102; MPV: 10.2; MCHC: 352; Na: 137.1; K: 3.89; Cl: 104.7; CB: 42.2; ALB: 25.3; nrbc: 0.6; NRBC# AB: 0.03;
01.09.26: PDW: 10.1; leu: 5.72; ery: 2.5; Hb: 77; htk: 0.22; MCV: 90; MCH: 30.8; RDW: 13.9; trc: 145; MPV: 9.8; MCHC: 342; Na: 139.9; K: 3.38; Cl: 104.8; nrbc: 0.2; NRBC# AB: 0.01;
03.09.26: Hgb 95 g/l, K 3.32 mmol/l, CB 45, Alb 25
05.09.26 HB 97, CRP 35

31.08.2026 Ambulance pro poruchy výživy

RES: Těžká hypoalbuminémie kom. etiologie - chronické ztráty GIT (průjem při onkologické léčbě) - stav po operaci (TEP). Dop.: z našeho hlediska po dobu pobytu na stand. oddělení vhodná podpora parenterální výživou (Olimel N4E 2000 ml na den, tedy kont. cca 100 ml/hod) + p.o. příjem podle možnosti + sipping 2 x denně + Protifar prášek (již dostává). Na následních lůžkách bude pak možnost pouze sippingu, případně práškový protein typu Protifar, Fresubin powder. Kontrola počtu stolic (ideál do 3 x denně), jistě lze vrátit Imodium do medikace 2-3 x denně, případně "Fričovy kapsle" 1-1-1. Naše kontrola podle potřeby. Kontrola laboratoře (tedy konkrétně výživových parametrů bílkovina + albumin za týden, běžná labor dříve).

Dále zápis Dr. Jarůška po konzultaci nutričního a onkol. Specialisty:

31.8. pro nízký albumin a bílkovinu doplněna anamnéza u pacientky - udává, že nežádoucím účinkem jejího léku Verzenios jsou průjemy, při průjmech užívala z doporučení onkologa Nutridrinky, aby se snížily ztráty bílkovin. Dále prosím o doplnění Imodia do medikace (průjemy v noci na dnešek 6x, Imodium z doporučení svého onkologa užívá) 31.8. lék Verzenios z doporučení onkologie FTN vysazen, (též s ohledem na st.p. reimplantaci dříku TEP), zpět do medikace až po zlepšení stavu pacientky 31.8. dále kontaktována nutriční ambulance - dr. Hanzlová - doporučuje sipping, Nutridrink 2x denně, každý lok zajíst

Mikrobiologie 28.8.2026 – perop. Odebrané vzorky – primokultivace negativní, prodloužené kultivace 4.9.

TERAPIE BĚHEM HOSPITALIZACE: Předoperační příprava včetně premedikace (Oxazepam tbl.), prevence TEN (Inhixa inj.), jako ATB profylaxe Azepo inj. 2 g i.v. s premedikací a do 24 hodin 1 g i.v. á 6 hodin, analgoterapie (afexil, palgotal, ibuprofen, paracetamol, morphine), chronická medikace, fyzioterapie, péče o ránu.

OPERACE:

Diagnóza: S7210 Periprotet.fr.prox.fem.vlevo Vanc B3, st.p. TEP 2008, OS 2015
Název operace: Revize, extrakce fem. komponenty, reimplantace Wagner
Operátor: MUDr. VÁCLAV VANĚČEK Ph.D.
Datum: 28.8.2026

DG SOUHRN:

Zákl. dg: S7210 Periprotet.fr.prox.fem.vlevo Van B3, reimp. dříku
Vedlejší dg: W0101 Pád na rov.po uklouz.n.zakop.; domov; volný čas
Y899 Následky neurčené vnější příčiny
T840 Mechanická komplikace vnitřní kloubní protézy
D62 posthemoragická anémie
B876 hypokalémie

EPIKRÍZA: Pacientka přijata k operačnímu řešení periprotetické fraktury femoru při TEP kyčle vlevo. Provedena revize, extrakce, cerklážní klíčky protektivní a reimplantace dřík dlouhý Wagner. Operace po zvyklé přípravě, bez komplikací, kontrolní RTG v pořádku. Pooperační průběh na CHIRJIP bez komplikací, na standardním oddělení řešena malnutrice (hypoalbuminémie a snížení celkové bílkoviny při chronické onkologické léčbě) – zaveden sipping a vysazení léčiva po konzultaci ošetřujícího onkologa. Dále podány 2x ERD pro anémii s normalizací hladiny hemoglobinu. 3.9. ozřejmění hypokalémie a zahájena substituce perorální s kontrolou mineralogramu. Operační rána se hojí PPI, pacientka schopna chůze o francouzských holích. Pacientka je v den ukončení hospitalizace afebrilní, kardiopulmonálně kompenzována, operační rána s reziduální

DOPORUČENÍ:

Pacientku překládáme dne 7.9.2026 na ORFM ÚVN k pokračování intenzivní pooperační rehabilitace. Při překládání je přítomna reziduální serózní sekrece z rány, pro kterou nasazena empirická atb profylaxe. Rána k časně kontrole naším konziliářem, viz níže.

7.9. dovolat K+C moč.

Kontrola rány á 2 dny.

Pokračovat v nutriční podpoře. Substituce hypokalémie

Pravidelná kontrola hemogramu, mineralogramu a nutričních parametrů.

Kontrola a převaz rány naším konziliářem za 2 dny.

Kontrola u operátora prim. MUDr. Vaněčka v ortopedické ambulanci ÚVN dne 8.10.2026 v 8.30 hod. (tel.

973203278).

Při potížích souvisejících s operačním výkonem — otok, zarudnutí, sekrece z rány či výrazná bolestivost operovaného kyčelního kloubu — kontrola dříve — pacientka poučena.
Klidový režim, chůze o dvou francouzských holích s odlehčením operované dolní končetiny, individuální cvičení dle edukace. Dle potřeby chladit operovanou oblast a končetinu udržovat ve zvýšené poloze.
Dodržovat prevenci vykloubení TEP dle edukace.

Následnou rehabilitační péči ústavní v místě bydliště doporučujeme.
Vzhledem k omezené hybnosti operovaného kloubu a porušenému stereotypu chůze je indikována komplexní lázeňská péče VII/10 s nástupem do 3 měsíců od operace — podání žádosti cestou praktického lékaře. Z ortopedického hlediska není známa kontraindikace k lázeňské péči.

U pacientů po opakovaných frakturách, či starších 65 let je vhodná suplementace vitamínem D a vápníkem jako prevence osteoporózy. Denní doporučená dávka je 800 IU vitamínu D3 a 1000 mg vápníku.
Prevence trombembolické nemoci — Inhixa 0.4 ml s.c. 1x denně do konce 6. pooperačního týdne

DOPORUČENÁ MEDIKACE:

FLONIDAN 10MG TBL NOB 10

EGILOK 25MG TBL NOB 60

VERZENIOS 100MG TBL FLM 28

EGISTROZOL 1MG TBL FLM 20

SORVASTA 20MG TBL FLM 30X1

VIDEMEL 600MG/400IU TBL FLM 90

LOPERON 2MG CPS DUR 20 I

PO 1-0-0 TBL V

PO 1-0-1 TBL V

PO 1-0-1 EX TBL V

PO 1-0-0 TBL V

PO 0-0-1 TBL V

PO 0-0-1 TBL V

PO d.p. CPS

při průjmech, pac. takto užívá z dop. onkologa, max do 8 tbl denně

NUTRIDRINK COMPACT PROTEIN S PŘÍCHUTÍ VANILKOVOU PO PO 1-0-1 LAH

s jídlem, každý lok zajíst, nepít samotné - prevence průjmu

PROTIFAR POR PLV 225G

PO 2-2-2 DAV

INHIXA 4000IU(40MG)/0,4ML INJ SOL ISP 10X0,4ML I SC 0-0-1 INJ

Amoksiklav TBL 1-1-1 od 7.9.2026 na 7 dní jako empirická profylaxe při protrahované sekreci z rány.

Pacientka opouští oddělení stabilizována.

Za převzetí pacientky děkujeme.

V Praze, dne: 07.09.2026

MUDr. Kamila Bušková
vedoucí lékař stanice I

prof. MUDr. Michal Fuček, Ph.D.
přednosta Kliniky ortopedie LF UK a ÚVN

